小结 AML 鉴别：

急粒部分分化 M_2	急早幼粒 M_3/APL	急单 M_5
骨髓原粒 30-89%	骨髓早幼粒≥30%	各阶段单核≥80%
最易绿色瘤 2绿3D我是鸭皮	最易 DIC、成堆 Auer 小体　分化得相对不错 CD13/33/117、9，不表达 CD34 和 HLA-DR　天天师兄	最易牙龈增生肿胀、皮肤紫蓝色结节 CD14
MPO/POX(-)～(+)　分化差可以(-) NSE(-)～(+) 找2 t(8;21)(q22;q22)→$RUNX_1$-$RUNX_1T_1$	MPO/POX 强(+)　撤种子要三思 NSE(-)～(+)　主要见于单核细胞 t(15;17)(q22;q12)→PML-RARA	MPO/POX(-)～(+) NSE(+)且 NaF 抑制(+)

五、急性白血病的治疗

（一）防治高尿酸血症肾病

白血病细胞被破坏→嘌呤分解为尿酸→尿酸浓度↑→聚集在肾小管

规律

24 小时持续静脉补液，碱化尿液，化疗同时给予别嘌呤醇

特殊:(酸化)肝性脑病稀醋酸灌肠、磷酸盐结石与感染有关

竞争性抑制黄嘌呤氧化酶(嘌呤分解为尿酸的关键),进而抑制嘌呤的分解

（二）白细胞淤滞症的治疗

①紧急用血细胞分离机单采清除过高的白细胞（但 M_3 型不推荐）回输的血液中有抗凝剂,M3凝血障碍(最易并发DIC)

②不宜立即输红细胞纠正贫血　会增加血液粘度

白细胞>10×10^9/L称为白细胞增多的白血病;白细胞>100×10^9/L称为白细胞淤滞症;白细胞<1×10^9/L白细胞不增多的白血病

（三）M_3 型的治疗

靶点:RARA　靶点:PML

（1）全反式维甲/A 酸 ATRA+三氧化二砷 ATO+蒽环类。缓解后上述药物交替维持治疗（单用维甲酸易复发）

诱导进一步分化成熟

小剂量:可以诱导M3型白血病细胞分化

大剂量:诱导细胞凋亡

（2）全反式维甲酸的不良反应——分化综合征 WBC释放细胞因子→介导发生SIRS

①易发生在患者初诊时白细胞较高及治疗后迅速上升者

②SIRS 的发热、低血压、胸腔和心包积液、ttsx 体重增加、肌骨痛、呼吸窘迫、急性肾衰竭

③暂停 ATRA，给糖皮质激素、吸氧、利尿

MDS中的RAEB、RAEB-t向急性髓系白血病转化风险较高→需要联合化疗(蒽环类+阿糖胞苷)

（四）联合化疗

AML（除 M_3 型）	ALL
化疗前用羟基脲、水化进行短期预处理（水枪）	化疗前用地塞米松、水化进行短期预处理（领地）
（买益达哈）　预防因白血病细胞大量破坏所导致的高尿酸血症肾病;减轻化疗药的不良影响 IA（伊达比星+阿糖胞苷）I-1 DA（柔红霉素+阿糖胞苷）D-red HA（高三尖杉酯碱+阿糖胞苷）H-high	（儿童 VIP）（GC 减少酸雨降临） VP（长春新碱+泼尼松）　GC:减少嗜酸性粒细胞和淋巴细胞 DVP（柔红霉素+长春新碱+泼尼松） DVLP（柔红霉素+长春新碱+左旋门冬酰胺酶+泼尼松）
高三尖杉酯碱只能用于治疗 AML（高-High-Max）	左旋门冬酰胺酶只能用于治疗 ALL（左-Left）

AML: ①“酶-mei”:急淋没有MPO、NSE②“M倒过来像3”:髓系标志CD13CD33③“买益达哈”④“高-High-Max”

（五）防治感染

化疗放疗后粒细胞缺乏：G-CSF 用于 ALL、老年强化疗或伴感染的 AML　集落刺激因子

有M0-M7,教材介绍急性髓系白血病时默认是急粒(M1、M2、M3),这三组本身是粒细胞增多,再用集落刺激因子可能让粒细胞不受控制

（六）化疗后结局

1.完全缓解（CR）：白血病表现（症状和体征）消失、无髓外白血病、外周血无原始细胞、外周血中性粒细胞＞1×10^9/L、血小板≥100×10^9/L、骨髓三系造血恢复（原始细胞＜5%）　我 3 科都没错、考 100 分得第 1